Resumos de Pediatria



Batistaz

Revisão Flash · Emergência

Parada Cardiorrespiratória

Suporte básico e avançado de vida pediátrico

Internato de Pediatria

10º período · 2026.2

Parada cardiorrespiratória pediátrica

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

Na criança a parada quase sempre vem de hipóxia ou choque: reconheça em 10 segundos, comprima forte e rápido, ventile com O2 a 100%, separe ritmo chocável de não chocável e dê adrenalina 0,01 mg/kg.

1. **PCR:** inconsciente, apneia ou gasping, sem pulso (braquial ou carotídeo) em ≤ 10 s.
2. **Com pulso:** FC < 60 + má perfusão apesar de ventilar = comprimir.
3. **Compressão:** 100–120/min, ⅓ do tórax (~4 cm lactente, ~5 cm criança).
4. **Relação (SBC):** 30:2 sozinho, 15:2 em dupla; via avançada: contínua.
5. **Não chocável:** assistolia, AESP: adrenalina o mais cedo possível.
6. **Chocável:** FV, TV sem pulso: SBC 2–4 J/kg (até 10); ERC 4 J/kg.
7. **Adrenalina:** 0,01 mg/kg = 0,1 mL/kg da 0,1 mg/mL; máx. 1 mg; 3–5 min.
8. **Após o RCE:** SpO2 94–98%, CO2 normal, PA, temperatura, UTI.

Doses que caem

Droga	Dose
Amiodarona PCR	5 mg/kg bolus
Lidocaína	1 mg/kg
Atropina	0,02 mg/kg
Adenosina	0,1 → 0,2 mg/kg
Magnésio	25–50 mg/kg

Pegadinha

Recém-nascido é outro algoritmo: 3:1 e adrenalina 0,02 mg/kg.

Checklist antes do plantão

- ☐ Reconheço PCR em 10 s
- ☐ Comprimo com pulso quando devo
- ☐ Sei a relação sozinho e em dupla
- ☐ Separo chocável de não chocável
- ☐ Calculo adrenalina em mL
- ☐ Calculo a energia do choque
- ☐ Lembro as 4 H e 4 T
- ☐ Trato TSV estável e instável
- ☐ Sei as metas após o RCE